

Bris dentaires périanesthésiques

Introduction, méthodologie & légende



Champ : prévention et conduite à tenir devant un bris dentaire périanesthésique — RFE commune SFAR, Association des anesthésistes réanimateurs pédiatriques d'expression française (Adarpef), Société française de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale (SFSCMF). Texte court, **31 propositions** réparties sur 3 chapitres / 10 questions : facteurs prédictifs de bris dentaires (consultation préanesthésique, traçabilité, information du patient), prévention au bloc opératoire (choix du protocole, matériel de contrôle des voies aériennes, protection dentaire, surveillance péri- et postopératoire), conduite à tenir devant un bris dentaire constaté (prise en charge immédiate, traçabilité, déclaration, information du patient).

Méthodologie : ce document ne comporte **aucun système GRADE** (pas de tag « GRADE », pas de suffixe 1+/2+ nulle part dans le texte). La source imprime **une seule mention de force, globale**, immédiatement après l'introduction : « Toutes les propositions ont reçu un accord fort lors des votes par le groupe de travail. » Il n'existe donc pas de distinction fort/faible entre propositions individuelles — chaque proposition est chippée « Fort » de façon uniforme (extension locale de la légende de ce site, jamais un GRADE numérique inventé). La formulation verbale de chaque proposition (« il faut » / « il faut probablement » / « il ne faut probablement pas » / « il ne faut pas ») est reprise telle quelle depuis la source ; elle reflète une nuance de rédaction, pas une force de vote distincte formellement définie par le document.

Légende

Fort

Toutes les 31 propositions du texte ont reçu un **accord fort** lors du vote du groupe de travail — seule mention de force imprimée par la source, globale et non individuelle (voir disclosure méthodologique ci-dessous).

Bris dentaires périanesthésiques

Chapitre 1 — Facteurs prédictifs



Chapitre 1 — Facteurs prédictifs de bris dentaires

Q1 — Spécificités de la consultation préanesthésique

N°	Proposition	Accord
1	Rechercher les critères d'intubation difficile et de ventilation au masque difficile.	Fort
2	Rechercher lors de l'interrogatoire les facteurs de risque de bris dentaires : existence de prothèses, de restaurations (dent naturelle antérieure restaurée par résine composite ou facette collée — élément très fragile) et de traitement orthodontique, de mobilité des dents et des prothèses, ou d'antécédents traumatiques ou parodontaux.	Fort
3	Insérer probablement des questions relatives à l'état buccodentaire dans un questionnaire rempli par le patient en vue de la consultation d'anesthésie.	Fort
4	Porter une attention particulière aux incisives supérieures et inférieures, notamment en cas de dent isolée lors de la consultation d'anesthésie.	Fort

Q2 — Traçabilité des signes cliniques prédictifs

N°	Proposition	Accord
5	Consigner les signes prédictifs d'intubation et de ventilation au masque difficile dans le compte rendu de la consultation d'anesthésie.	Fort
6	Consigner de façon compréhensible (schéma dentaire simplifié conseillé) les signes relatifs à l'état dentaire sur le dossier d'anesthésie.	Fort

Q3 — Classes de risque & conduite à tenir de prévention

N°	Proposition	Accord
7	Informé le patient du risque dentaire, et lui suggérer en cas de risque identifié une prise en charge par un odonto-stomatologiste avec panoramique dentaire. Chez un patient à risque avec traitement en cours ou prévu, évoquer le report d'intervention chirurgicale ou des soins dentaires dans l'information sur le rapport bénéfice-risque.	Fort
8	Il ne faut probablement pas adresser systématiquement le patient chez le dentiste et/ou le stomatologue dans les autres cas.	Fort

Proposition enfant : chez l'enfant, en cas de traitement orthodontique en cours limitant l'ouverture de bouche (type bielle de Herbst fixe), ou présentant un obstacle au niveau du tiers antérieur du palais (grilles antilangue, antisuccion) avec un risque de bris et d'inhalation et/ou de matériel pouvant être abîmé au cours de l'acte chirurgical intrabuccal (bistouri électrique, ouvre-bouche), il faut probablement demander un avis spécialisé (possibilité de suspendre le traitement ou de démonter le dispositif) en dehors d'un contexte d'urgence.

Q4 — Traçabilité de l'information donnée au patient

N°	Proposition	Accord
9	Informé oralement et remettre un document au cours d'une consultation d'anesthésie précisant que les traumatismes dentaires sont possibles au cours de toute anesthésie. La preuve de cette information doit être consignée dans le dossier d'anesthésie, au moins pour les patients avec risque de bris dentaire identifié.	Fort
10	La note d'information remise au patient doit lui recommander de signaler toute prothèse ou toute fragilité dentaire particulière, notamment au niveau des incisives supérieures et inférieures.	Fort

Proposition enfant : en cas d'accès aux voies aériennes potentiellement difficile chez un enfant, informer les parents du risque de luxation accidentelle d'une dent temporaire ou d'une dent définitive immature.

Bris dentaires péri anesthésiques

Chapitre 2 — Au bloc opératoire



Chapitre 2 — Au bloc opératoire

Q5 — Prévention lors du choix du protocole d'anesthésie & traçabilité

N°	Proposition	Accord
11	Au vu de l'ensemble des risques évalués, proposer une stratégie de prise en charge anesthésique dans le dossier.	Fort
12	Pour améliorer la qualité des soins et la gestion du risque, mettre en place une stratégie d'équipe pour diminuer l'incidence des bris dentaires.	Fort
13	En cas de risque de bris dentaire identifié, favoriser la pratique de l'anesthésie locorégionale dans le cadre de l'analyse bénéfice/risque.	Fort
14	Obtenir un relâchement musculaire optimal pour faciliter les conditions d'intubation trachéale.	Fort

Proposition enfant : chez l'enfant entre 3 et 14 ans, rechercher avant l'induction de l'anesthésie une éventuelle dent temporaire devenue mobile depuis la consultation d'anesthésie, en vérifier l'état aux différents temps périopératoires (après l'intubation jusqu'à la sortie de la salle de soins postinterventionnels) et tracer l'information dans le dossier.

Q6 — Matériel de contrôle des voies aériennes supérieures

N°	Proposition	Accord
15	En cas d'intubation et/ou de ventilation au masque difficile prévue, tenir compte de l'état dentaire dans la stratégie de contrôle des voies aériennes supérieures.	Fort
16	En cas de risque identifié de bris dentaire et en l'absence de difficulté de ventilation au masque, il ne faut probablement pas utiliser systématiquement une canule oropharyngée.	Fort
17	Avoir probablement recours à des solutions alternatives à une canule oropharyngée pour la prévention de la morsure de la sonde (compresses roulées).	Fort
18	En cas de risque identifié de bris dentaire, le contrôle des voies aériennes doit être assuré par un opérateur expérimenté.	Fort
19	Si une anesthésie générale est décidée et que l'indication s'y prête, privilégier probablement le choix d'un dispositif supraglottique.	Fort
20	Si une intubation de la trachée est indiquée, utiliser probablement une lame de laryngoscope type Macintosh métallique pour une intubation par laryngoscopie conventionnelle.	Fort
21	Après discussion avec le patient et pour limiter le risque de bris dentaire, recommander probablement l'utilisation d'une protection dentaire (gouttière) — tenir compte, dans son choix, de l'épaisseur du dispositif qui peut rendre l'accès aux voies aériennes plus difficile.	Fort
22	Si l'utilisation d'une gouttière est retenue, recommander probablement une gouttière sur mesure plutôt qu'une gouttière standard, et tracer l'information « incité à fournir un protège-dents sur mesure » dans le dossier (délai de réalisation et coût pour le patient, libre d'accepter ou de refuser).	Fort

Proposition enfant : chez l'enfant, utiliser une lame de laryngoscope dont la taille est la mieux adaptée à sa morphologie, notamment en présence de dents fragilisées (maladie carieuse précoce). En période néonatale, éviter d'exercer une pression avec la lame du laryngoscope au niveau de la gencive du maxillaire supérieur — risque d'altération/lésion des germes dentaires ou de déplacement de germes.

Q7 — Surveillance péri- et postopératoire de l'état dentaire

N°	Proposition	Accord
23	Pour les patients présentant un risque dentaire identifié, tracer probablement l'absence de dommage dentaire directement visible lié à l'anesthésie.	Fort
24	En cas de risque de bris dentaire élevé, l'extubation trachéale doit probablement être réalisée par un opérateur expérimenté chez un patient complètement réveillé, sans curarisation résiduelle, et avec une ventilation spontanée efficace.	Fort

Bris dentaires périanesthésiques

Chapitre 3 — Conduite à tenir & sources



Chapitre 3 — Conduite à tenir devant un bris dentaire

Q8 — Que faire en cas de bris dentaire ?

N°	Proposition	Accord
25	Si une luxation complète (dent totalement sortie de son alvéole) d'une dent définitive est constatée, la remettre probablement en place rapidement ou la conserver dans du sérum physiologique ou, si disponible, dans une Hank's Balanced Salt Solution (HBSS — conservation dans un milieu isotonique au desmodonte à température ambiante), et demander un avis spécialisé dans le plus bref délai.	Fort
26	En cas de bris dentaire constaté : prendre en charge une éventuelle complication (inhalation ou ingestion, radiographie thoracique éventuelle) et la traiter ; conserver si possible la dent ou ce qu'il en reste dans du sérum physiologique ; conserver les prothèses descellées et les restaurations.	Fort

Proposition enfant : chez l'enfant, il ne faut pas réimplanter une dent temporaire en cas de luxation complète.

N°	Proposition	Accord
27	Au décours d'un traumatisme dentaire : proposer un avis spécialisé avec panoramique dentaire ; établir un constat descriptif et factuel des lésions dans le dossier du patient (sans opinion ni jugement personnel) ; informer le patient rapidement, noter sa réaction et ses réponses ; garder pour soi-même un aide-mémoire détaillé et conserver les photocopies du dossier complet.	Fort
28	Prendre probablement des photographies des lésions et les conserver.	Fort
29	En cas de dommage constaté par le patient ultérieurement sans avoir été constaté en périopératoire : le patient doit être reçu par le professionnel ou un représentant de l'établissement de santé pour être informé sur les causes et circonstances du dommage, dans les 15 jours suivant la découverte du dommage ou la demande du patient ; récupérer un éventuel panoramique antérieur à l'acte anesthésique ; prévoir un avis spécialisé.	Fort

Q9 — Déclaration de bris dentaire

N°	Proposition	Accord
30	Le praticien doit effectuer, selon son mode d'activité, une déclaration de bris dentaire auprès de son assurance civile professionnelle, ou du service qualité / gestion des événements indésirables (ou service de contentieux) de son établissement.	Fort

Q10 — Documents et information à remettre au patient

N°	Proposition	Accord
31	Apporter une information claire au patient, l'accompagner et lui fournir : les coordonnées du service qualité et relation avec les usagers de son établissement ; la radio panoramique effectuée en postopératoire ; les coordonnées du dentiste ou stomatologue ayant constaté l'incident.	Fort

Le groupe de travail suggère que les propositions 1, 2, 3, 6, 9, 11 et 23 puissent faire l'objet d'une évaluation des pratiques professionnelles (EPP).

Sources et traçabilité

Document source : « Bris dentaires périanesthésiques : texte court » — RFE commune Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR), Association des anesthésistes réanimateurs pédiatriques d'expression française (Adarpef), Société française de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale (SFSCMF). K. Nouette-Gaulain, F. Lenfant, D. Jacquet Francillon, A. Belbachir, et al. Ann Fr Anesth Reanim 2012;31:272-275, doi 10.1016/j.annfar.2012.01.003. Disponible sur Internet le 24 février 2012.

Méthodologie : pas de système GRADE — propositions rédigées par un groupe d'experts, validées par les comités des référentiels cliniques et le CA de la SFAR ; « toutes les propositions ont reçu un accord fort lors des votes par le groupe de travail » (mention globale, non individuelle — voir disclosure méthodologique en page 1).

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 31 propositions numérotées du texte court, réparties sur les 3 chapitres / 10 questions (facteurs prédictifs, prévention au bloc opératoire, conduite à tenir devant un bris dentaire constaté), ainsi que les 5 encarts « Proposition enfant » pédiatriques. Comité d'organisation, déclaration d'intérêts et formulaires d'accompagnement (EPP, diaporama pédagogique, déclaration de bris dentaire — disponibles sur cfar.org / sfar.org) ne sont pas retranscrits (sans contenu clinique actionnable au-delà de ce que la fiche cite déjà).

Bris dentaires périanesthésiques

Chapitre 3 — Conduite à tenir & sources



Avertissement — document de 2012 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des 31 propositions du texte source, mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, principales références) et n'est ni éditée ni validée par la SFAR, l'Adarpef ou la SFSCMF. En cas de bris dentaire constaté, utiliser le formulaire de déclaration disponible sur sfar.org et l'joindre au dossier du malade ; en cas de doute, se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé (odonto-stomatologiste, chirurgien maxillo-facial).